

41. 実践2 結腸の枠組み

所要時間：03:23

学習シート

コース概要

帝王切開後の身体再活性化テクニックの紹介。結腸フレームと腹膜に焦点を当てる。筋膜の均一性を回復するための、組織および熱反応を含む腹部の触診。骨盤介入（例：子宮摘出術）後に必要となる終末支点、組織解放、および動的調整の分析。調和のとれた組織再統合を促進するための臨床的方法論。

実践2：結腸フレーム

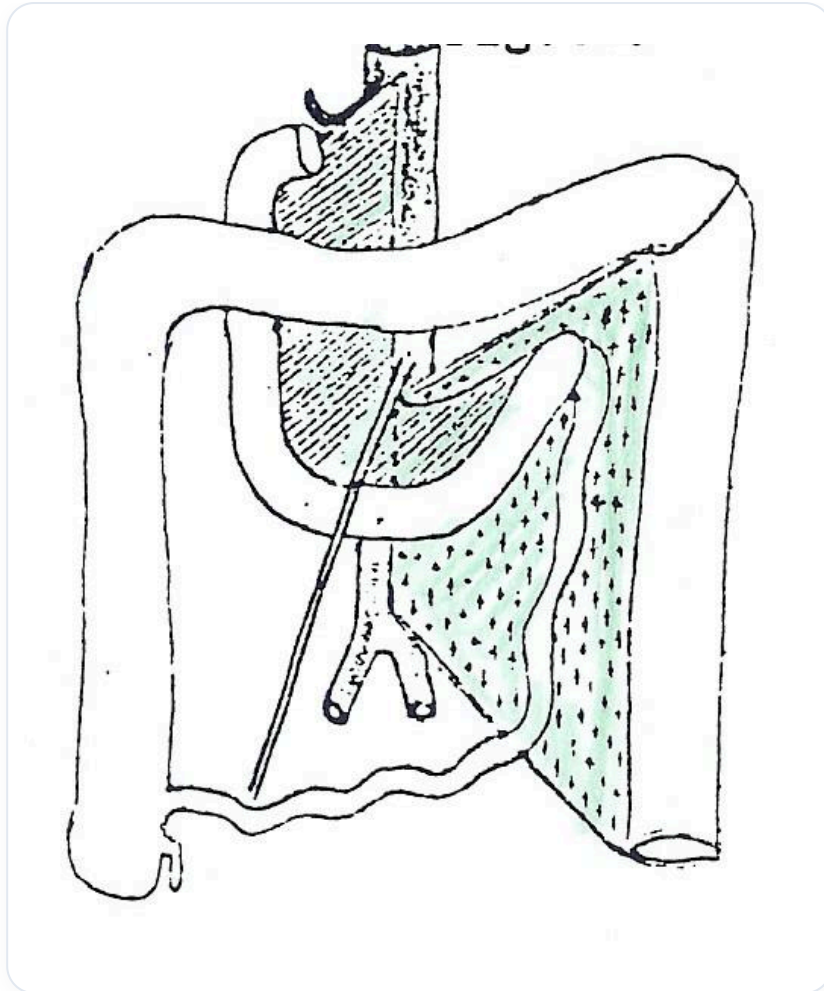
帝王切開は身体を上下に切断するため、**再活性化**が必要です。子宮は**後部壁側腹膜**の集中を表します。腹膜の発達の過程で、集中と力が再中心化し、**終末支点**を形成します。この支点は胚的であると同時に最終的でもあり、それらを意識に戻すことが重要です。

触診の際、両手で腹部全体を包み込み、手を十分にリラックスさせることが不可欠です。呼吸が浅すぎる場合、**控えめな要求**を示している可能性があります。感じられる**熱**は施術者と患者の間の交換であり、組織が情報を提供し始めます。組織が防御的になると、下部領域はリラックスし始めますが、上部にはまだ均一性が欠けています。目標は均一な状態を取り戻すことです。

熱が増加すると、すべての力線が子宮領域に向かうように見え、まるで組織がその**巣**に再統合されるかのようです。これは、患者が自分の土地に縛られている人のように、**内なる家**に戻るのを助けます。この段階で、施術者は接触を全身に広げ、**治療プロセス**を開始できます。子宮領域への統合が強化され、手の間に大きな均一性が生まれます。

子宮摘出術の場合、身体のダイナミクスが変化し、患者は**バッファローハンプ**を発症する可能性があります。これには、いくつかの領域での再均衡が必要です。作業は組織のポイントに焦点を当て、組織の解放と同期した発達を可能にします。特に**横隔膜**に異なる働きをさせ、他の空間と開口部を探すためには、支持点が不可欠です。

施術者は、肝臓やS状結腸などの特定の領域に取り組むことで、完全なリラックスを可能にします。



図一 結腸の解剖